SDD 243 Sujet n°1

Spécialité : Orthopédie

Date : 29/09/2024
Auteur(s) : Chloé Fèvre (DES médecine générale, EN 2024), Alexandre Lannoy (DES neurologie, EN 2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EN 2024)

Domaine d'apprentissage principal	Education et prévention
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de prise en charge
Item(s) en lien avec la station	Item 365 - Surveillance d'un malade sous plâtre/résine
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 243 - Mise en place et suivi d'un appareil d'immobilisation
Matériel nécessaire à la station	0
Contexte de la station	Consignes post-réalisation d'un plâtre aux urgences

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne aux urgences et vous recevez Mr G., 60 ans, pour prise en charge d'une fracture bimalléolaire droite. Il s'agit d'un boulanger qui livre ses clients tous les matins. Il n'a pas d'antécédents pertinents dans ce contexte et il ne prend pas de traitement.

Dans le cadre de sa prise en charge, vous réalisez une botte plâtrée pour immobiliser sa cheville.

Consignes :
Au cours de cette station, vous avez 8 minutes pour :

- réaliser l'éducation thérapeutique du patient en citant les principaux conseils à donner au porteur d'un plâtre
- énoncer les différentes mesures médicamenteuses et non médicamenteuses à mettre en place dans ce contexte

Vous ne devez pas :

- Réaliser l'anamnèse de l'accident
- Réaliser l'examen physique du patient standardisé.

Cet ECOS est avec un patient standardisé (PS).

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

	Aptitudes cliniques	
1.	Explique les règles d'hygiène et de précautions suivantes : - ne pas gratter dessous - ne pas mettre d'objet dedans - ne pas mouiller le plâtre - ne pas rouler de vêtements au-dessus du plâtre Au moins *2 éléments sur 4*	1 pt
2.	Conseille de surélever le plâtre les premiers jours.	1 pt
3.	Proscrit le redécoupage ou le retrait du plâtre par le patient lui-même (au moins un élément).	1 pt
4.	Conseille la réalisation d'auto-exercices du membre immobilisé (*à titre d'exemples : contractions isométriques, mobilisation des articulations sus et sous-jacentes*)	1 pt
5.	Ne pas marcher sur le plâtre dans les 36-48h.	1 pt
6.	Proscrit la conduite automobile.	1 pt
7.	Énonce les consignes de reconsultation en urgence : - fièvre et/ou odeur nauséabonde (signes infectieux) - douleur non soulagée par un antalgique - rougeur du membre - décoloration et/ou froideur des extrémités - déficit sensitivo-moteur - dyspnée et/ou douleur thoracique Au moins *3 éléments sur 5*.	1 pt
8.	Recherche une intoxication tabagique	1 pt
9.	Propose une prise en charge de sevrage tabagique	1 pt
10.	Propose un arrêt de travail.	1 pt
11.	Prescrit une anticoagulation préventive (*le nom de la molécule n'est pas attendue)*.	1 pt
12.	Prescrit une antalgie.	1 pt
	Communications et attitudes	

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie

TOTAL	**16 points**

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes interne aux urgences et vous recevez Mr G., 60 ans, pour prise en charge d'une fracture bimalléolaire droite. Il s'agit d'un boulanger qui livre ses clients tous les matins. Il n'a pas d'antécédents pertinents dans ce contexte et il ne prend pas de traitement.

Dans le cadre de sa prise en charge, vous réalisez une botte plâtrée pour immobiliser sa cheville.

Identité du patient :

Mr G., 60 ans

Mode de vie :

Boulanger
Vit en pavillon avec sa femme et son chien
Consommation d'alcool
Tabac : 10 cigarettes/j depuis 20 ans
0 allergie

Comportement global :

Ouvert à la discussion et préoccupé par son accident.

Antécédents personnels :

0

Antécédents familiaux :

0

Médicaments :

0

Motif de la venue :

Mr G. a trébuché sur une branche d'arbre au cours d'une balade en forêt.
Devant une incapacité à se déplacer suite à cet accident, il décide de se rend urgences.

Symptômes positifs :

- Douleur ++
- Déformation
- Impotence fonctionnelle

Questions de relance :

- Si les traitements n'ont pas été évoqués au bout de 7 minutes : "*Docteur, j'avais une question. Est-ce que je dois prendre des traitements pour les jours qui viennent ?*"